精巣超音波検査を契機に診断し得たリヒター症候群の１例

◎出口 和樹[1)]、髙田 彩永[1)]、渡邉 颯真[1)]、大島 康平[1)]、伊藤 亜子[1)]、関根 綾子[1)]、大澤 徳子[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】リヒター症候群は，小リンパ球性リンパ腫／慢性リンパ性白血病（chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma : CLL/SLL）が，びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma : DLBCL）などの高悪性度リンパ腫へ形質転換する病態である。
今回我々は，精巣超音波検査を契機に診断し得たリヒター症候群の１例を経験したので報告する。
【症例】70 歳代男性。CLL/SLL の治療後，当院血液内科にて経過観察中であった。頻尿の自覚症状が出現したため，泌尿器科へ紹介となった。
【超音波検査】左精巣の腫大と圧痛を認め，超音波検査にて左精巣内に 43×43mm 大の腫瘤性病変を認めた。腫瘤は境界明瞭で辺縁はやや不整，内部エコーは不均一であった。また，精巣外浸潤所見は認めなかった。カラードプラ法にて腫瘤内部に豊富な血流シグナルを認めた。
【PET-CT 検査】左精巣に FDG 集積を伴う腫瘤性病変を認めた。内部に壊死あるいは嚢胞変性を反映する集積欠損域を伴っており，超音波検査所見と併せて悪性リンパ腫が疑われた。後日，高位精巣摘除術が施行された。
【病理組織検査】病理組織診断では，大型異型リンパ球様細胞がびまん性に増殖していた。免疫染色では CD20，CD79a，MUM1，BCL6 が陽性，CD3，CD5，CD10 が陰性であったことから，DLBCL と診断された。CLL/SLL の既往および臨床経過を踏まえ，リヒター症候群と臨床的に診断された。
【考察】リヒター症候群の発生頻度は，CLL/SLL 患者の約 2～8%と報告されており，リヒター症候群へ形質転換した際，腫瘤を形成しやすい部位はリンパ節，骨髄や肝臓などである。精巣に腫瘤が形成される頻度は極めて稀であり，症例報告は限られている。CLL/SLL 患者の経過観察中において，他の臓器で悪性を疑う腫瘤性病変を認めた場合は，リヒター症候群による形質転換も念頭において超音波検査を行うことが重要である。

連絡先：058-230-6000　内線 7261